

一、疾病理解與病理機轉

您可能同時面臨多種健康挑戰,包括心臟功能減退導致血液輸送不足的心衰竭、腎臟功能衰退無法有效清除體內廢物的末期腎臟疾病,以及血糖控制不佳的糖尿病。這些狀況會相互影響,心衰竭可能導致水腫和呼吸困難,腎功能衰退會造成水分和電解質不平衡,糖尿病則可能影響神經和血管健康。身體各系統需要共同努力維持平衡,當某個系統功能下降時,其他系統也會受到影響,因此需要全面的照護管理。

二、藥物知識與服藥遵從

1. 請按時服用所有處方藥物,包括心衰竭用藥、降血糖藥、降血壓藥和腎臟相關藥物,不可自行調整劑量或停藥
2. 服用磷結合劑時請咬碎後與食物一起食用,每吃一兩口食物就配一小塊藥物,確保充分混合
3. 使用胰島素的病人需要定期監測血糖,作為調整劑量的依據
4. 了解每種藥物的作用、使用時間和可能的副作用,如有不適立即告知醫護人員
5. 記錄長期用藥記錄卡,就醫時主動告知醫師目前服用的所有藥物,包括西藥、中草藥和營養補充品

三、警訊辨識與處置行為

1. 若一日體重增加1公斤或一周增加2公斤以上,可能表示水分滯留加重,需立即聯繫醫療團隊
2. 出現呼吸困難加重、無法平躺、心悸或胸悶時,應立即就醫評估心臟狀況
3. 下肢水腫加劇、腹脹噁心、食慾不振或虛弱無力時,可能是心腎功能惡化的警訊
4. 發燒、寒顫或關節紅腫劇痛快速惡化時,需緊急返院檢查感染或痛風急性發作
5. 意識改變、持續噁心嘔吐、胸悶喘或呼吸困難時,可能是嚴重的代謝異常,需要立即處理

四、飲食與活動建議

1. 嚴格限制水分攝取,避免水腫加重心腎負擔,同時限制鹽分控制在每日2-4公克
2. 採用低鉀飲食,避免濃湯、高湯、蔬果汁、咖啡、茶、運動飲料和含鉀高的食物
3. 執行低磷飲食,避免加工食品如香腸、火腿、起司、汽水、啤酒和內臟類食物
4. 選擇新鮮雞鴨魚肉、嫩豆腐、豆包等優質蛋白質來源,避免紅肉和海鮮
5. 適度活動如散步、舉手運動,每天進行腹式呼吸和噘嘴呼吸訓練各10分鐘,每週3次
6. 每日清潔雙腳並檢查皮膚狀況,選擇棉質吸汗襪子和寬頭透氣鞋子,避免足部受傷

五、出院追蹤與門診照護導引

1. 定期回診追蹤心臟、腎臟和糖尿病狀況,攜帶血糖、血壓、體重記錄供醫師參考
2. 每日測量並記錄血壓、脈搏、體重變化,監測病情穩定狀況
3. 控制良好的糖尿病患者每週驗血糖1-2次,控制不良時每天驗4次(三餐前及睡前)
4. 諮詢營養師設計個人化飲食計畫,確保營養均衡同時符合低鉀低磷限制
5. 出現任何症狀變化或用藥不適時,立即聯繫醫療團隊(02)2737-2181相關分機
6. 保持規律透析治療(如有需要),並注意管路照護以避免感染

六、慢性疾病追蹤與照護提醒

【個人化慢性疾病追蹤與照護提醒】

以下慢性病是依診斷 ICD-10 自動辨識,請配合醫師門診追蹤與用藥調整。

■ 心臟衰竭(ICD-10: I5023)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日測量體重,若一天增加 1 公斤或一週增加 2 公斤以上,需立即聯繫醫療團隊。
- 限制液體攝取(依醫師指示)及鹽分(每日 < 2 公克),戒菸限酒。
- 出現呼吸困難加重、無法平躺、下肢水腫加劇時,需緊急就醫。

■ 心律不整(ICD-10: I482)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 避免菸、酒、濃茶、咖啡等刺激性物質,這些可能誘發心律不整。
- 出現持續心悸、胸悶、頭暈、昏厥時,應立即就醫並記錄發作時間與症狀。
- 抗心律不整藥物不可自行調整劑量或停藥,定期回心臟科門診追蹤心電圖。

■ 慢性阻塞性肺疾病(ICD-10: J449)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日進行腹式呼吸與噁嘴呼吸訓練,每次10分鐘,每天3次,可增加活動耐力。
- 依醫師指示使用吸入型支氣管擴張劑,正確使用吸藥器是治療關鍵。
- 出現呼吸急促明顯惡化、痰量或痰色改變、發燒時,需立即就醫。

■ 高血脂症(ICD-10: E785)

- 目前用藥中可能包含降血脂藥物,請按時服用;若有明顯肌肉痠痛或茶色尿,請告知醫療人員。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 減少高膽固醇及飽和脂肪攝取,選擇清蒸、水煮等低油烹調方式,增加膳食纖維。
- 規律運動(每週至少3次,每次30分鐘以上),維持理想體重。
- 按時服用降血脂藥物,不可自行增減劑量或停藥;定期抽血追蹤膽固醇數值。

■ 第二型糖尿病(ICD-10: E1122)

- 目前用藥中可能包含降血糖藥或胰島素,請規律監測血糖,並留意冒冷汗、手抖、心悸等低血糖症狀。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 依醫師指示定時測量血糖,餐前目標 80~130 mg/dL,餐後2小時目標 < 160 mg/dL。
- 詳細記錄每次血糖值(日期、時間、餐前/後、藥物劑量),回診時提供醫師調整劑量。
- 每日檢查雙腳皮膚,選擇棉質吸汗襪與寬頭透氣鞋,避免赤腳或穿夾腳拖。

■ 高血壓(ICD-10: I129)

- 目前用藥中可能包含心血管或血壓相關藥物,請勿自行停藥;若有頭暈、胸悶、喘或心悸,請提早回診。
- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 每日早晚各量一次血壓,遵循 722 原則(7天、每日早晚各1次、每次量2遍),記錄後回診時提供醫師參考。
- 每日鹽分攝取限制在 2~4 公克,採用 DASH 飲食(多蔬果、全穀、低脂)。
- 規律服用降壓藥,不可自行停藥或減量;戒菸、限酒、維持 BMI 20~25。

■ 慢性腎臟病(ICD-10: N183)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 採低磷、低鉀飲食(視腎功能分期調整),蔬菜煮熟後倒掉湯汁可降低鉀含量。
- 嚴格限制液體及鹽分攝取,避免使用止痛藥(NSAIDs)或來路不明的中草藥。
- 定期回診追蹤腎功能(尿素氮、肌酸酐、電解質),準時接受透析治療(若需要)。

■ 高尿酸血症/痛風(ICD-10: M109)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 急性發作時,患部冰敷、抬高並休息;遵醫囑使用秋水仙素或類固醇緩解疼痛。
- 少吃紅肉、內臟、海鮮、啤酒等高嘌呤食物;腎功能允許時每日飲水 > 2000 mL。
- 長期降尿酸藥物(Allopurinol 或 Febuxostat)需規律服用,目標尿酸 < 6 mg/dL。

■ 攝護腺肥大(ICD-10: N401)

- 目前用藥中可能包含抗凝血或抗血小板藥物,若出現黑便、血尿、異常瘀青或流血不止,請立即就醫。
- 避免憋尿、減少睡前飲水量;咖啡因和酒精可能加重症狀,建議減少攝取。
- 按時服用 α 阻斷劑或 5 α 還原酶抑制劑,需數週才能看到效果,不可自行停藥。
- 若出現完全無法排尿(急性尿滯留),需緊急就醫。

七、參考衛教手冊

1. 血糖自我監測衛教指導
2. 水腫的照護
3. 住院病人就醫安全守則
4. 準備低鉀飲食
5. 低磷飲食
6. 心衰竭
7. 糖尿病足部病變護理指導
8. 慢性阻塞性肺疾病
9. 泌尿道感染
10. 心臟節律不整

11. 高血脂症護理指導
12. 高血壓
13. 末期腎臟疾病
14. 痛風護理指導
15. 攝護腺肥大

※ 此衛教手冊由人工智慧輔助生成，僅供參考，不代替醫師專業建議。

生成日期：2026-05-31